Diskussion 772

Datum: 1936-03-20
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Alfred Andersson (Socialdemokraterna, man)

I anledning av föreliggande utskottsbetänkande har jag inte mycket att säga, men jag skall dock, herr talman, be att få belysa motivet till den motion, jag har väckt i denna fråga.

Av vissa skäl har jag under en lång följd av år varit syneman vid bland annat klockarboställen, som det här gäller, och det har varit en ganska sorglig syn, man mött vid dessa besiktningar. Att det i själva verket är så illa ställt på detta område, torde i mångt och mycket bero på att boställsinnehavaren, klockaren, icke själv är lantbrukare, varför bostället utarrenderats. Redan detta har då medfört, att boställsinnehavaren har fått sin inkomst minskad, ty arrendatorn och hans familj måste ju också leva på detta lilla lantbruk. Boställsinnehavaren har dock fått behålla byggnadsskyldigheten för dessa boställer, men underhållsplikten har naturligtvis överförts på arrendatorn genom arrendekontraktet. Av ekonomiska skäl har varken boställshavaren eller arrendatorn kunnat på ett tillfredsställande sätt fylla sin uppgift i fråga om byggnadsskyldighet eller underhållsplikt, och följden av detta har blivit, att byggnaderna på dessa klockarboställen ha råkat i svårt förfall. Jag skall med tre exempel, samtliga från Herrestads härad, närmare belysa, hur det kan gå under sådana förhållanden med klockarboställena.

Det ena gäller Stora Herrestads församling. Sista gången jag var på besiktning där, fanns det kvar ett hus, boningshuset, men enligt hälsovårdsnämndens beslut fick ingen människa lov att bo där. Alltså hade klockaren i

Det andra fallet gäller Högestads församling, också i Herrestads härad. Där finnas två boställshavare, därför att pastoratet består av två församlingar. Boställshavarna äro två folkskollärare, och de visade vid senaste besiktningen, att de utav viss anledning voro befriade från byggnadsplikt. Och märkvärdigt nog kunde församlingen på samma sätt styrka, att inte heller församlingen hade någon byggnadsskyldighet. Alltså fanns det ingen byggnadsskyldighet i den församlingen, men underhållsplikten låg ju kvar på arrendatorn, som i detta fall var en **änka²** med två oförsörjda barn. Det var huvudsakligen detta fall, som gjorde, att jag kände mig föranlåten att väcka en motion i kammaren för att på detta sätt ge frågan en liten stöt framåt. Boningshuset på detta boställe var inte så särskilt anmärkningsvärt; det var tämligen bra underhållet. Uthusen däremot hängde formligen på stöttor — tar man bort dem, falla dessa hus absolut ihop — och tak saknades i mycket stor utsträckning. Grödan var visserligen bärgad men delvis förstörd genom regn, sedan den

kommit under tak.

Det tredje fallet gällde mitt eget pastorat, där klockaren, märkvärdigt nog, själv skötte jordbruket, trots att han var en gammal man. Han hade en vuxen pojke, som tog hand om lantbruket, och han var alltså både byggnadspliktig och underhållsskyldig, men ingen av dessa uppgifter kunde han fylla i någon grad. Han var ekonomiskt illa ställd, och vart femte år, då vi kommo på besiktning till detta boställe, hade bristerna ökats i stället för att minskas. Och så en vacker dag föll ett av dessa hus, och den byggnadspliktige boställsinnehavaren saknade medel att bygga nytt. F öljden blev, att dessa båda församlingar fingo tillskjuta nödigt belopp för att bygga upp ett nytt hus åt klockaren. Det är, som sagt, på grund av dessa förhållanden, som jag icke kunde underlåta att med denna motion till den kraft och verkan den hava kunde föra frågan ett stycke framåt.

Nu säger utskottet, att utskottet saknar anledning att komma fram med förslag i detta ärende, därför att det kommit till utskottets kännedom, att Kungl. Maj:t har frågan under övervägande och en ny utredning i detta ärende snarast möjligt skall vara att förvänta. Med den förklaringen får Jag ju också känna mig nöjd. Jag skulle endast be att få hemställa, att Kungl. Maj:t snarast möjligt ville vidtaga åtgärder för att så fort som möjligt åstadkomma en bättre sakernas ordning på detta område.

Jag har, herr talman, intet yrkande.

2. Wilhelm Källman (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Denna fråga, som nu genom vår motion framförts i riksdagen, har mycket stor betydelse ur åtskilliga synpunkter, och det kanske tillgives mig, att jag för den skull säger några ord utöver vad som är framhållet i motionen och vad som framkommit genom utskottets utlåtande.

Motionärerna vilja — jag vågar kalla det så — skapa ordning på ett viktigt område av socialförsäkringen. Den svenska sjukförsäkringen måste anses vara av den allra största betydelse, vilket också mycket allmänt erkännes. Ju flera människor som sjukförsäkra sig, ju större möjlighet för folk att under sjukdom ekonomiskt reda sig själva. Det talas ju så mycket i våra dagar om understödstagaranda och allt vad därmed sammanhänger, men den miljon sjukför-

Bestämmelserna om sjukvårdsersättning ha emellertid blivit mycket betungande för de erkända sjukkassorna, och vi veta ju alla, att detta är 1931 års lagstiftning i ämnet. Om läkare föreskriver sjukhusvård, så är vederbörande sjukkassa utan vidare skyldig att likvidera dagavgiften på sjukhus, såvitt det är fråga om vård å allmän sal. Det tillkommer här en detalj av den allra största betydelse, nämligen att **hustrun²** till sjukförsäkrad man kan få bli medlem 1 sjukkassa för att allenast erhålla sjukvårdsersättning, d. v. s. sådan sjukvård på vederbörande sjukvårdsinrättningar, som sjukkassan är skyldig att betala. Jag kan nämna ett exempel på vad det kan betyda i tunga för sjukkassan. Jag har här stadgarna för Södra

Sveriges erkända centralsjukkassa. Enligt dessa stadgar kan en **hustru²** få vara sjukvårdsförsäkrad, för såvitt **hon²** är direkt ansluten medlem, för 35 öre i månaden och, såvida det gäller indirekt ansluten medlem, för endast 25 öre per månad. Vi förstå alla, att avgiften per år blir ganska obetydlig. Emellertid är sjukkassan skyldig att för en sådan medlem i värsta fall betala sjukvårdsersättning under en tid av — det gäller i flertalet centralsjukkassor — intill två år, i Stockholms stad intill tre år. Årsavgiften går då åt till en å två dagars sjukvårdskostnader. Då är det ju uppenbart, att genom sådana bestämmelser — och det är ju riksdagen, som fastställt dem — sjukkassan i vissa fall blir alltför hårt betungad. Jag fäster uppmärksamheten på att i praktiken blir det på det sättet, att bara det uppges hos en lasarettssyssloman eller annan vederbörande, att den sjuke tillhör sjukkassa vare sig det är vanliga sjukkassemedlemmar eller enbart sjukvårdsförsäkrade, så behövs det ingen ansvarsförbindelse och ingen förskottsbetalning, utan sjukkassan likviderar sjukvårdsavgiften för så lång tid, det är fråga om, intill visst maximum.

Detta måste anses få mycket stor betydelse för sjukhusens ägare. Det är sjukhusens ägare, som få fördelarna av vad som här är stadgat. Stockholms stad har beräknat att under ett år få in cirka 600,000 kronor, som sjukkassorna erlägga i sjukvårdsersättning för medlemmar, tillhörande stadens erkända centralsjukkassa.

Nu ha vi emellertid i olika landstingsområden väsentligt olika sjukvårdsavgifter. Sjutton olika landsting ha, som vi framhållit i motionen, olika beräkningsgrunder, och dagkostnaden på allmän sal växlar mellan 50 öre och 5 kronor. Detta måste betraktas som orimligt ojämnt, och det måste betyda en kraftig prestation från sjukkassornas sida, i synnerhet när legosängsavgiften är mycket hög.

Jag skall anföra såsom ytterligare exempel, att inom Östra Sveriges erkända centralsjukkassas verksamhetsområde, som omsluter tre län, äro sjukvårdsavgifterna olika och högst väsentligt olika. I Stockholms län har landstinget sedan snart 20 år en dagavgift för sjukvård på allmän sal av kr. 1:50 för de 30 första dagarna och av 1 krona för tiden därefter. Den sistnämnda nedsättningen i avgiften är tillkommen för att lätta avgiftsbördan för dem, som ligga sjuka länge. Gotlands läns landsting, som också tillhör detta område, har bestämt en avgift av kr. 2 per dag under de första 30 dagarna och därefter kr. 1:25. Uppsala läns landsting har fastställt en differentierad avgiftsskala, beroende på storleken av vederbörandes inkomst. Där är emel-

Vi ha bjudit till att inom vår landstingsförvaltning söka på frivillighetens väg lösa frågan om enhetliga sjukvårdsavgifter, men det har icke lyckats. Vi sammankallade förra sommaren representanter för Uppsala och Gotlands läns förvaltningsutskott och hade flera konferenser med dem. Men det visade sig vara omöjligt att på frivillighetens väg åstadkomma en enhetlig legosängsavgift.

Nu innebära emellertid dessa olika avgifter också det, att medlemmar av sjukkassa i län med lägre legosängsavgift få betala en del av kostnaden för sjukkassemedlemmars i andra län

sjukvård. Utskottet erkänner, »att det nuvarande avgiftssystemet är ur sjukkassesynpunkt förenat med olägenheter». Ja, det torde väl vara det minsta man kan säga — det är inte bara olägenheter ideellt sett, utan det är också fråga om olägenheter av betydande ekonomisk innebörd för en frivillig verksamhet sådan som sjukkasserörelsen. Styrelsen för svenska sjukkasseförbundet hade trott sig kunna få frågan ordnad genom hänvändelse till landstingsförbundets styrelse. Emellertid föranledde denna hänvändelse i slutet av förra året icke någon annan åtgärd än att man underrättade landstingens förvaltningsutskott om sjukkasseförbundsstyrelsens framställning, varav en avskrift bifogades.

På grund av de erfarenheter, som vunnits beträffande svårigheterna att frivilligt lösa frågan om enhetliga legosängsavgifter i de tre län, jag nyss talat om, och med hänsyn till att landstingsförbundets styrelse inte vidtog någon allvarlig åtgärd 1 anledning av sjukkasseförbundets framställning, ha vi framfört frågan genom motion till årets riksdag. Vi känna till att frågan är svårlöst, och vi ha icke begärt omedelbar lagstiftning, men vi betrakta en utredning såsom 1 högsta grad befogad, ehuru vi anse, att det inte är så lätt för enskilda att åstadkomma en sådan utredning, som i och för sig inte är märkvärdig att göra. Den får emellertid inte någon auktoritet, såvida den icke sker genom statsmakternas försorg.

Nu vågar jag anse, att frågans vikt hade bort giva utskottet anledning att tillstyrka en utredning. Det gäller ju, som jag förut påpekat, mycket, mycket stora värden.

LTandstingsförbundets styrelse, på vars yttrande utskottet stöder sig, ställer sig både ovillig och välvillig till den väckta motionen — ovillig på grund av att landstingsförbundets styrelse fruktar ett ingrepp i landstingens självstyrelse. Denna fruktan tror jag är åtskilligt obefogad. En begränsning uppåt av legosängsavgiftens storlek enligt sjukhuslagens 17 8 kan icke anses vara annat än ett mycket obetydligt ingrepp i landstingens självstyrelse. Jag vill bland annat erinra om att vi ha många restriktioner redan nu i det avseendet; sålunda ha vi t. ex. för vården av kroniskt sjuka icke rättighet att taga mera än en viss högsta dagavgift av dem, som begagna sig av sådan vård. Och när det är fråga om landstingsförvaltningen för genomförande av distriktssjukvården, har ju medicinalstyrelsen fått tillfälle att rent av göra landstingens självstyrelse i fråga om förvaltningen till en chimär. Man har skapat sådana bestämmelser i 1935 års distriktssjukvårdskungörelse, att det praktiskt taget är omöjligt för landstingen att åstadkomma en centralisation, om de också önskade det. Man pekar ut vilka personer, som skola utgöra styrelsen, så att den och den intressegruppen skall vara representerad, och landstingens frihet att själva utse förvaltningsstyrelse är mycket kringskuren.

Distriktssjukvårdens genomförande var den första etappen i fråga om socialhygienisk verksamhet. Det kommer tre grupper till efter den, och i stort

Nu säger man emellertid, att då blir det fråga om villkor för statsbidrag. Ja, gärna det, men hur stor kan skillnaden egentligen vara? Jo, om de 25 landstingen och de 6 större städer, som

icke deltaga i landsting, praktiskt taget uppbära genom den stadgade sjukvårdsersättningen statens bidrag till sjukförsäkringen, bör man ha rätt att stadga såsom ett villkor för sjukvårdsersättningens praktiska genomförande, att landstingen icke få upptaga mera än ett visst belopp i avgift för vård av sjuka på allmän sal.

Med avseende på vad jag nu senast anfört måste det vara uppenbart, att en mängd överdrifter förekomma i landstingsförbundets styrelses yttrande. Man har där, å ena sidan, icke beaktat innebörden av den väckta motionen, men man har, å andra sidan, fullkomligt överdrivit det relativt obetydliga ingripande i landstingens självstyrelse, varom här är fråga.

Nu är emellertid landstingsförbundets styrelse välvillig i ett annat avseende, och denna välvilja tar sig uttryck i att styrelsen lovar att framföra denna fråga till årets landstingsförbunds möte. Ett sådant möte hålles, som bekant, vart tredje år, och år 1936 är turen inne. Styrelsen meddelar också, att det har gjorts framställning »från landstingshåll om förbundets medverkan» och att frågan har blivit aktuell. Jag vet inte vad som menas med »från landstingshåll» här. Jag kan emellertid tala om att båda motionärerna i denna kammare och motionären i andra kammaren äro mycket verksamma såsom landstingsmän, icke minst i landstingsförvaltningen, och det kan ju hända, att motionen därför är att betrakta såsom en framställning från landstingshåll. I varje fall borde den kunna vara det. Jag är nu emellertid en smula rädd för att det kommer att dröja rätt länge, innan åtgärder bliva vidtagna, som leda till det mål, som vi önska nå. Vi ha nämligen inte minst erfarenhet om landstingsförbundets verksamhet beträffande åstadkommandet av läkartaxor vid lasarettspoliklinisk verksamhet. Åtta år hava gått, sedan man började att syssla med den frågan, och något resultat föreligger ej ännu.

Nu kanske man emellertid får nöja sig med att den fråga det nu gäller har fått en mycket kraftig stöt framåt. Jag anser, att motionen medfört den stora nyttan, även om den kommer att avslås, att frågan har blivit allvarligt aktuell, och jag förväntar, att vid landstingsförbundets möte i höst — det brukar hållas i slutet av året — ärendet skall bliva föremål för en mycket omsorgsfull prövning, vilket måhända så småningom kan leda till att det blir åtminstone maximerade avgifter för sjukkassemedlemmar och att man inte såsom nu kan taga en dagavgift av ända upp till 5 kronor.

Med hänsyn till frågans läge, herr talman, skall jag icke tillåta mig att framställa något yrkande.